

分子標的治療薬

分類・作用点・副作用

1 薬剤の分類マップ

小分子TKI(経口) 細胞内のキナーゼを阻害	EGFR・ALK(肺癌)	エルロチニブ	オシメルチニブ	アレクチニブ	ロルラチニブ
	BCR-ABL(白血病)	イマチニブ	ダサチニブ	ニロチニブ	
	マルチキナーゼ	レンバチニブ	ソラフェニブ	レゴラフェニブ	
抗体薬(注射) 細胞外の受容体・リガンドに結合	抗HER2抗体	トラスツマブ	ペルツマブ	抗EGFR抗体	セツキシマブ
	抗VEGF・VEGFR-2抗体	ベバシズマブ	ラムシムマブ		
抗体薬複合体(ADC) 抗体で運び細胞内で薬剤を放出	抗HER2 ADC	T-DM1	T-DXd		
	その他のADC	ダトパマブ デルクステカン	エンホルツマブ ベドチン	ポラツズマブ ベドチン	
その他の経口標的薬 細胞周期・DNA修復などを阻害	CDK4/6阻害薬	パルボシクリブ	アベマシクリブ	PARP阻害薬	オラパリブ
	mTOR・AKT阻害薬	エベロリムス	カビバセルチブ	ニラパリブ	

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 代表的な薬剤群の副作用とモニタリング

EGFR阻害薬 代表薬 オシメルチニブ・アファチニブ 特徴的な副作用 ゴ瘡様皮疹・爪囲炎・下痢・ILD モニタリング(薬局で確認できること) 皮膚症状、排便回数、咳・息切れ	ALK阻害薬 代表薬 アレクチニブ・ロルラチニブ 特徴的な副作用 筋肉痛・CK上昇/脂質異常症・気分変化 モニタリング(薬局で確認できること) 筋肉痛、脂質の検査値、気分の変化(家族にも)	マルチキナーゼ阻害薬 代表薬 レンバチニブ・レゴラフェニブ 特徴的な副作用 高血圧・蛋白尿・手足症候群・肝障害 モニタリング(薬局で確認できること) 家庭血圧、尿蛋白、手足の症状、肝機能値
抗HER2療法 代表薬 トラスツマブ・T-DXd 特徴的な副作用 心機能低下/間質性肺疾患 モニタリング(薬局で確認できること) 息切れ・むくみ、心エコーの予定、咳	CDK4/6阻害薬 代表薬 パルボシクリブ・アベマシクリブ 特徴的な副作用 好中球減少/下痢 モニタリング(薬局で確認できること) 血液検査値、排便回数、発熱	PARP阻害薬 代表薬 オラパリブ・ニラパリブ 特徴的な副作用 貧血・悪心(ニラパリブは血小板減少・高血圧も) モニタリング(薬局で確認できること) 息切れ・ふらつき、血液検査値、血圧

3 副作用の特徴と発現時期

	開始日	1週	2週	1か月	3か月	半年～
● インフュージョンリアクション(抗体薬)	投与中～24時間					
● 下痢(アベマシクリブ・EGFR阻害薬)	開始数日～2週					
● ゴ瘡様皮疹(EGFR阻害薬)		1～2週で出現				
● 高血圧(血管新生阻害薬)		開始数週				
● 手足症候群(マルチキナーゼ阻害薬)			開始1か月以内に多い			
● 爪囲炎(EGFR阻害薬)					1～2か月以降	
● 心機能低下(抗HER2療法)					治療期間を通じて	
● 間質性肺疾患						時期を問わず起こりうる

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

- 分子標的薬は小分子(経口)・抗体(注射)・ADCに分かれ、経口TKIは相互作用が多い
- 副作用は標的分子の生理機能を反映(EGFR=皮膚・下痢、VEGF=血圧・蛋白尿、HER2=心機能)
- 経口TKIの服用時点・相互作用・服薬継続の支援は、保険薬局が最も力を発揮する領域